

GUIDA / PRESENTAZIONE

Osservazione del pasto e delle abilità alimentari

ARMONIA · OPA v1.0 · Edizione editoriale del 03/10/2026

Una raccolta strutturata per descrivere il pasto nelle sue condizioni reali: ambiente, partecipazione, alimenti, azioni visibili e informazioni della persona o di chi la assiste.

01 Per chi e in quali situazioni

Per logopedisti con competenze pertinenti all'età e alla situazione clinica, nell'ambito del lavoro del servizio e dell'équipe. La scheda può organizzare osservazioni di bambini, adolescenti e adulti durante pasti già previsti; non stabilisce aspettative uguali per tutte le età.

La versione OPA non è un protocollo per allattamento, suzione nutritiva neonatale, gestione del biberon, nutrizione enterale o somministrazione di farmaci. Questi aspetti possono essere richiamati come contesto, ma richiedono percorsi specifici.

Scheda osservativa non standardizzata — non è una diagnosi di disfagia

Non sostituisce valutazione clinica completa, valutazioni strumentali quando indicate o protocolli validati. Non attesta la sicurezza della deglutizione, non autorizza l'alimentazione orale e non prescrive consistenze, volumi, posture o manovre. Nessun punteggio, soglia o risultato automatico.

02 Come è organizzata

Guida G1–G11. Uso, limiti, spiegazioni, esempi fittizi e fonti. Leggere G3 prima dell'osservazione.

Scheda S1–S12. Contesto, panoramica, registri selezionabili e sintesi. S10 documenta eventi, interruzioni e azioni: non è una scheda di triage.

Le fonti orientano i principi generali; non validano questi campi originali. Stato editoriale e limiti della revisione: G11.

GUIDA / MODALITÀ D'USO

Osservare, non provocare una prova

Le pagine organizzano una raccolta professionale: non sono una sequenza di somministrazione.

01 Prima del pasto · S1

Definisci la domanda; consulta le indicazioni cliniche e alimentari disponibili, incluse limitazioni, allergie e assistenza prevista. Se l'alimentazione orale non è prevista, non è chiarita o vi sono nuovi dubbi clinici, non introdurre assaggi per compilare OPA: raccogli le fonti e confrontati con il referente.

02 Identifica pasto e alimenti · S1, S3

Attribuisci un codice al pasto (P01) e agli alimenti o bevande presenti (A01, A02). Mantieni preparazioni e supporti previsti, senza ampliare consistenze, porzioni o richieste per "vedere come va". La sola familiarità di un alimento non ne certifica l'appropriatezza attuale.

03 Raccogli episodi e fonti · S4–S10

Descrivi ciò che accade con attività, momento e aiuto effettivo. Un codice episodio E01 permette di richiamare la stessa evidenza. L'eventuale registrazione non equivale all'osservazione dal vivo: segnala inquadratura, audio e parti mancanti.

04 Ritorna alla panoramica · S2

Scrivi una nota nelle aree esplorate. Puoi richiamare P01/A01/E01; non devi completare tutte le aree. Un evento rilevante richiede prima l'azione appropriata, non il completamento delle caselle.

05 Concludi e condividi · S12

Riporta risorse, bisogni, limiti e domande aperte. Registra chi è stato informato, che cosa va approfondito e chi se ne occupa. Le decisioni cliniche appartengono al percorso professionale, non al risultato della scheda.

I codici sono soltanto riferimenti documentali: non sono punteggi. Per lo stesso pasto mantieni gli stessi codici anche sulle pagine duplicate. Audio/video sono facoltativi e vanno gestiti secondo le procedure del servizio, senza link pubblici nei campi.

La sicurezza viene prima della scheda

Indicazioni di prudenza per l'uso di OPA, non un algoritmo di triage o un manuale di primo soccorso.

L'assenza di tosse non esclude l'aspirazione

L'aspirazione può avvenire senza segni evidenti. Anche tosse o cambiamenti vocali, da soli, non ne dimostrano la presenza. La verifica dell'aspirazione e l'analisi della fisiologia deglutitoria richiedono approfondimenti appropriati, inclusi esami strumentali quando indicati. [1, 2]

01 Non avviare o proseguire per completare i campi

Rispetta le indicazioni vigenti e la volontà della persona. Un divieto di assunzione orale, informazioni cliniche essenziali non chiarite o condizioni nuove preoccupanti non si superano con una prova alimentare. Non somministrare acqua, nuovi cibi, quantità crescenti o consistenze diverse come verifica di sicurezza.

Se durante l'assunzione compaiono segni nuovi o preoccupanti, interrompi l'offerta e attiva il referente clinico secondo piano e procedure del servizio. Non riprendere con un altro alimento "per provare". Rifiuto o richiesta di pausa vanno rispettati: non sono automaticamente un'emergenza.

02 In caso di emergenza, agisci prima di documentare

Una difficoltà respiratoria acuta importante, un sospetto soffocamento con respiro o tosse inefficaci, alterazioni marcate del colorito o della coscienza richiedono l'attivazione immediata dei soccorsi e delle procedure di emergenza del setting. L'elenco non è esaustivo. Non attendere di compilare OPA e non usarla per decidere le manovre di soccorso. [5]

03 Registra fatti, interventi e passaggio delle informazioni · S10

Annota momento, alimento, segno concreto, cambiamento rispetto alla situazione iniziale, azioni, persone contattate e risposta ricevuta. Tosse, voce modificata, dolore, residui o affaticamento sono osservazioni da contestualizzare, non diagnosi. [1, 2]

Anche senza segni durante il campione, difficoltà persistenti riferite, riduzione dell'apporto, problemi di crescita o calo ponderale, disidratazione sospetta o episodi respiratori ricorrenti richiedono attenzione clinica appropriata. Non attendere un punteggio OPA, che non esiste. [1, 2]

GUIDA / FONTI E ALIMENTI · S1-S3

Sapere che cosa è stato osservato

Prima di descrivere un'abilità, identifica fonte, alimento e condizioni effettive.

Fonti distinte. Usa "Diretta dal vivo", "Diretta da registrazione", "Riferita dalla persona", "Riferita dal caregiver" o "Documentale". Specifica data, autore e periodo. Il resoconto di un altro pasto non diventa un evento osservato oggi.

SITUAZIONE	COME SCRIVERLA
Non esplorato	La voce non è stata indagata; puoi lasciarla vuota o dichiararlo. Non significa abilità assente.
Non osservabile	Indica perché: visibilità insufficiente, alimento non presente, interruzione o altra limitazione.
Non pertinente	La voce non riguarda la domanda o il pasto attuale; non è un livello di abilità.
Evidenza disponibile	Descrivi azione, contesto, supporti e fonte. "Non rilevato" va circoscritto a cosa e quando hai osservato.

A Descrizione di alimenti e bevande · S3

Registra denominazione, preparazione, componenti, eventuali parti solide/liquide insieme, forma e dimensioni osservate, temperatura rilevata o riferita, utensile e presentazione. "Morbido", "liquido" o "cremoso" sono descrizioni, non attestazioni di conformità o sicurezza.

Quantità. Distingui offerto, rimasto, disperso e apparentemente assunto; specifica se sono misure, stime o resoconti. La scomparsa dalla bocca o dal piatto non dimostra che tutto sia stato deglutito; non ricavare automaticamente adeguatezza nutrizionale o idrica.

IDDSI: solo un eventuale riferimento esterno documentato

OPA non applica i test IDDSI e non assegna livelli dall'aspetto del cibo. Se riporti un livello, identifica separatamente la sua fonte: piano, etichetta o verifica documentata, con data e riferimento disponibili. Il livello previsto dal piano non prova che quella preparazione sia stata verificata. Per lo standard e le risorse ufficiali, consultare IDDSI. [3]

La descrizione di una preparazione in OPA non è una ricetta, un'indicazione dietetica o un consiglio su dimensioni adatte a una persona.

GUIDA / SETTING E AUTONOMIA · S4

Postura, ambiente e accesso al pasto

Descrivi la configurazione reale e ciò che la persona fa con i supporti disponibili.

01 Postura e setting

Che cosa osservare. Come la persona è sistemata e raggiunge cibo, bevande e interlocutori; quali elementi ambientali accompagnano l'episodio.

Che cosa annotare. Seduta, appoggi di piedi, bacino, tronco e capo per quanto visibile; tavolo, distanza dagli oggetti, illuminazione, rumore e persone presenti. Segna eventuali cambiamenti e chi li ha effettuati.

Esempio fittizio. P01: seduta abituale con appoggio del tronco; il piatto è raggiunto senza spostarlo. Dopo alcuni minuti il tronco si inclina e il caregiver interviene secondo il piano già documentato.

Limite di lettura — La scheda non identifica una postura universalmente corretta e non prescrive posizioni compensatorie. Non modificare gli appoggi soltanto per creare un confronto.

02 Autonomia, utensili e assistenza

Che cosa osservare. Azioni specifiche: prendere o tenere il contenitore, caricare l'utensile, portarlo alla bocca, scegliere, chiedere aiuto, regolare una pausa.

Che cosa annotare. Utensile abituale o adattato, azione iniziata dalla persona, preparazione dell'ambiente, aiuto verbale o fisico effettivamente fornito e risposta. Distingui scegliere da eseguire il movimento.

Esempio fittizio. La persona tiene il cucchiaino; il caregiver stabilizza il piatto. Il trasporto alla bocca è avviato dalla persona. Il supporto riguarda il piatto, non tutta la sequenza.

Limite di lettura — Non assegnare un grado globale di dipendenza. Un ausilio può consentire autonomia; la sua presenza non è un errore.

La valutazione del pasto considera anche ambiente, posizionamento e attrezzature abituali; OPA ne raccoglie soltanto una descrizione contestuale. [1, 2]

Accettazione, esplorazione e preferenze

Il pasto non è una prova di obbedienza; il contatto con il cibo non obbliga all'assunzione.

03 Accettazione ed esplorazione sensoriale

Che cosa osservare. Azioni rivolte al cibo già presente: guardare, avvicinare, toccare, annusare, assaggiare, assumere, allontanare o rifiutare. Sono possibilità descrittive, non passi obbligati.

Che cosa annotare. Alimento A__, situazione precedente, azione concreta, segnali di consenso, disagio o richiesta di pausa e risposta del partner. Distingui un'azione spontanea da una proposta.

Esempio fittizio. Davanti ad A02 la persona avvicina il piatto, tocca il bordo e poi lo allontana. Il caregiver accoglie il gesto. Nessun assaggio viene richiesto per completare la voce.

Limite di lettura — Non dedurre ipersensibilità, fobia o causa del rifiuto da un singolo episodio. Non forzare l'apertura della bocca e non usare privazioni o pressioni per ottenere un dato.

04 Repertorio e routine riferiti

Che cosa osservare. Che cosa la persona o il caregiver descrivono come abitualmente presente nei pasti, con quali preparazioni e in quali contesti.

Che cosa annotare. Periodo di riferimento, alimento e preparazione, frequenza descritta, alternative disponibili, differenze casa/scuola/servizio e vincoli medici, pratici o culturali riferiti.

Esempio fittizio. Il caregiver riferisce che negli ultimi sette giorni A01 è stato assunto a casa in una preparazione specifica; non dispone di informazioni sul pranzo scolastico.

Limite di lettura — Un pasto non rappresenta il repertorio complessivo. Il numero di alimenti non diagnostica selettività, disturbi della nutrizione o disfagia.

Descrivere il messaggio, senza attribuire intenzioni

Registra “gira il capo e dice basta” invece di “si oppone”. La letteratura professionale pediatrica invita a leggere i segnali di rifiuto anche come comunicazione e a considerare l'interazione con il caregiver. [2]

GUIDA / AZIONI ORALI VISIBILI · S6–S7

Morso, masticazione e gestione orale

La registrazione si limita a quanto realmente accessibile durante il pasto.

05 Morso e masticazione · S6

Che cosa osservare. Eventuale distacco di una porzione e movimenti visibili della mandibola durante la gestione dell'alimento previsto.

Che cosa annotare. Alimento, forma, utensile, modo di introdurre la porzione, movimenti, pause e frammenti visibili. Specifica se il morso non era richiesto, per esempio perché il cibo era già porzionato.

Esempio fittizio. A01 era già porzionato: morso non esplorato. Si osservano movimenti mandibolari alternati a pause; la lingua non è visibile nel campione.

Limite di lettura — Movimenti esterni non dimostrano triturazione completa, forza o coordinazione adeguate. Non attribuire un livello di sviluppo dalla sola forma del movimento.

06 Gestione del bolo e residui visibili · S7

Che cosa osservare. Contenimento, perdite anteriori, movimenti orali effettivamente visibili ed eventuali resti di alimento accessibili allo sguardo.

Che cosa annotare. Sede visibile, momento e alimento; eventuale espulsione, permanenza osservabile e azioni spontanee della persona. Se il cavo orale non è visibile, scrivi “non osservabile”, non “assenza di residui”.

Esempio fittizio. Dopo l'assunzione di A01 si vede un frammento sulla superficie interna del labbro inferiore. La persona lo rimuove con un movimento spontaneo; altre sedi non sono osservabili.

Limite di lettura — Non forzare l'ispezione e non introdurre dita o utensili per completare OPA. Residui orali visibili e residui faringei non sono la stessa informazione.

La fase faringea non si deduce dalla sola osservazione esterna

Questa scheda non misura il transito faringeo, non verifica la protezione delle vie aeree e non esclude residui non visibili. Un eventuale approfondimento clinico o strumentale appartiene a una valutazione appropriata, non a una conclusione automatica di OPA. [1, 2]

GUIDA / TEMPI ED EVENTI · S8, S10

Andamento, fatica e cambiamenti

Tempo misurato, impressione osservativa e sensazione riferita restano informazioni differenti.

07 Tempi del pasto e affaticamento · S8

Che cosa osservare. Sequenza delle assunzioni e delle pause, cambiamenti nei movimenti o nel coinvolgimento e richieste di interrompere.

Che cosa annotare. Inizio/fine del pasto se noti, intervallo osservato, pause e loro ragione quando disponibile. Distingui “riferisce stanchezza” da “appoggia il capo”; non chiamare automaticamente fatica ogni pausa.

Esempio fittizio. Il pasto è iniziato prima dell'arrivo del logopedista. Sono osservati 12 minuti: al nono la persona dice “sono stanco” e posa l'utensile; la richiesta di pausa viene accolta.

Limite di lettura — La durata osservata non è la durata totale. Non sono previsti tempi normativi né un numero di masticazioni da raggiungere. I conteggi sono soltanto descrittivi.

08 Eventi da documentare e azioni · S10

Che cosa osservare. Qualsiasi cambiamento rilevante: per esempio tosse, schiarimento della voce, modifica vocale, dolore riferito, vomito, perdita di alimento o alterazione dello stato generale.

Che cosa annotare. Ora o fase, cosa precede l'evento, alimento, segno concreto e fonte. Mantieni distinto ciò che è visibile da espressioni come “è andato di traverso” riferite da altri. Registra l'azione e la persona avvisata.

Esempio fittizio. Alle 12:18 compare tosse durante il pasto. L'offerta viene interrotta; viene attivato il referente del servizio. L'evento è registrato dopo avere gestito la situazione, senza ulteriori assaggi osservativi.

Limite di lettura — Non è necessario riconoscere la causa per fermare un'osservazione preoccupante. La scheda non fornisce soglie per attendere, riprovare o decidere la ripresa.

Segni isolati non confermano né escludono aspirazione. Per prudenza, indicazioni e situazioni urgenti, consultare G3. [1]

GUIDA / CAREGIVER E CONFRONTI · S9, S11

Partecipazione e strategie nel contesto

La persona e il partner fanno parte dello stesso episodio, ma le loro prospettive restano distinte.

09 Caregiver, comportamento e comunicazione · S9

Che cosa osservare. Chi propone, attende, aiuta o risponde ai segnali. Come la persona sceglie, chiede, rifiuta, segnala dolore o termina il pasto, anche senza parole.

Che cosa annotare. Segnali concreti, parole o sistemi comunicativi usati; tempi lasciati dal partner, aiuti, preferenze e carico percepito riferito dal caregiver. Descrivi fatti senza valutare la “bravura” del familiare.

Esempio fittizio. La persona indica “pausa” sulla tabella comunicativa; il caregiver interrompe la proposta e lascia l’utensile sul tavolo. Il caregiver riferisce che a scuola la tabella non è sempre disponibile.

Limite di lettura — Una preferenza o un rifiuto non dimostrano incapacità. Non interpretare difficoltà alimentari come necessariamente comportamentali: aspetti medici, nutrizionali, abilità e contesto possono interagire. [6]

10 Strategie spontanee e confronto · S9, S11

Che cosa osservare. Azioni già messe in atto dalla persona e dal partner nel piano vigente: pausa, richiesta di aiuto o altro adattamento osservato.

Che cosa annotare. Chi avvia l’azione, motivo riferito, condizioni prima/dopo e risultato visibile. Per confrontare pasti diversi conserva alimento, preparazione, utensile, momento, fonte e assistenza.

Esempio fittizio. In P01 la persona chiede al partner di stabilizzare il piatto; in P02 il piatto è già fissato. I pasti differiscono anche per durata e alimento: non attribuire la differenza a una sola variabile.

Limite di lettura — Un beneficio osservato nella partecipazione non certifica sicurezza deglutitoria e non rende una strategia una raccomandazione generalizzabile.

Decisioni complesse sull’alimentazione richiedono documentazione e confronto centrati sulla persona e sull’équipe; OPA può richiamare il piano vigente, non sostituirlo né costituire un modulo di consenso. [4]

GUIDA / ESEMPI FITTIZI

Dall'episodio alla sintesi

Esempi esclusivamente illustrativi: non sono scenari da riprodurre, prove o suggerimenti di alimenti.

A Pasto con supporti abituali

Contesto. P01, bambino durante un pasto già previsto, senza introdurre nuovi alimenti o cambiare indicazioni. In S1 sono richiamate le informazioni cliniche pertinenti; in S3 sono descritti A01 e A02, non classificati per IDDSI.

Osservazione. E01: il bambino usa l'utensile abituale; il caregiver stabilizza il piatto. E02: tocca A02, poi lo allontana e segnala "basta". La richiesta viene accolta. Il periodo osservato è di 15 minuti; il pasto era già iniziato.

Informazione riferita. Il caregiver riferisce altri alimenti assunti a casa nella settimana precedente. Non sono stati osservati e non vengono aggiunti all'inventario diretto del pasto.

Esempio di sintesi circoscritta

Nel campione P01 sono documentati iniziativa nell'uso dell'utensile e comunicazione di rifiuto con risposta del partner. Non è noto l'intero repertorio né l'andamento del pasto fuori dall'intervallo osservato. Le informazioni non attestano la sicurezza della deglutizione. Priorità: chiarire le routine nei diversi contesti con le fonti pertinenti.

B Osservazione interrotta per un cambiamento

Contesto. P02, adulto con piano alimentare del servizio già disponibile; la scheda non modifica alimenti o assistenza.

Evento e azione. E03: durante il pasto compaiono tosse e una modifica vocale percepita rispetto all'inizio. L'offerta viene interrotta e viene attivato il referente clinico. In S10 si registrano orario, fatti, azioni e risposta ricevuta. Non si propongono altri assaggi per "confermare".

Sintesi. Campione interrotto e non utilizzabile per descrivere il pasto completo. L'episodio non dimostra aspirazione e non consente di escluderla. Il seguito clinico è documentato nel percorso del servizio, non derivato dalle caselle OPA.

In entrambi gli esempi, ciò che non è stato osservato rimane non esplorato o non osservabile. La sintesi evita "mangia in sicurezza", "nessun rischio" e "dieta adeguata".

GUIDA / FONTI E STATO EDITORIALE

Riferimenti e limiti dello strumento

Fonti consultate il 03/10/2026. I richiami [1]–[6] sostengono principi generali, non validano OPA.

[1] ASHA — Adult Dysphagia

Practice Portal. Segni clinici, limiti dell'osservazione e ruolo degli approfondimenti strumentali.

<https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/adult-dysphagia/>

[2] ASHA — Pediatric Feeding and Swallowing

Practice Portal. Contesto del pasto, abilità, interazione con caregiver e valutazione specialistica pediatrica.

<https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/pediatric-feeding-and-swallowing/>

[3] IDDSI — Sito e risorse ufficiali

Riferimento esterno per lo standard. OPA non riproduce né applica tabelle, test o algoritmi IDDSI.

<https://www.iddsi.org/>

[4] RCSLT — Eating and drinking with acknowledged risks

Principi di decisione condivisa e documentazione multidisciplinare nell'adulto; non una procedura normativa italiana.

<https://www.rcslt.org/members/clinical-guidance/eating-and-drinking-with-acknowledged-risks-risk-feeding/>

[5] NHS — Shortness of breath

Segnali di emergenza respiratoria nell'adulto e nel bambino. I percorsi di soccorso da usare sono quelli locali.

<https://www.nhs.uk/symptoms/shortness-of-breath/>

[6] Goday PS e colleghi — Pediatric Feeding Disorder

Consensus Definition and Conceptual Framework. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019;68:124–129. DOI: 10.1097/MPG.0000000000002188.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6314510/>

OPA v1.0 — edizione editoriale, non validazione clinica

Struttura, campi ed esempi sono stati redatti per ARMONIA. Non sono state eseguite revisione clinica specialistica, sperimentazione d'uso o validazione psicometrica di questo strumento. L'edizione definitiva riguarda la redazione e l'impaginazione; non equivale a validazione, certificazione o approvazione delle fonti citate.

Prima della diffusione per uso clinico ordinario è necessaria una revisione professionale specialistica adeguata ai contesti d'impiego. Nessuna pagina OPA sostituisce protocolli validati, procedure del servizio, valutazione clinica o strumentale. Non sono riprodotti moduli o criteri diagnostici delle fonti.

SCHEDA / CONTESTO E FONTI

Contesto della raccolta

Non è un'autorizzazione al pasto: riporta le informazioni pertinenti e ciò che resta da chiarire.

Codice persona / età

Professionista / servizio

Data/e e orario dell'osservazione

Data di compilazione / pasto P_____

Domanda osservativa e priorità della persona / caregiver

Luogo, tipo di pasto, persone presenti

Fonte: dal vivo / registrazione / riferita / documentale

Indicazioni cliniche e alimentari vigenti: fonte, autore, data e riferimento

Riporta quanto pertinente: eventuali limitazioni orali, consistenze previste, assistenza e piano individuale. Non generare indicazioni con OPA.

Allergie / restrizioni pertinenti e fonte

Informazioni cliniche nuove o non chiarite

Accesso e volontà: modalità per scegliere, chiedere aiuto, rifiutare e segnalare dolore

Stato iniziale osservabile e comfort riferito

Referente / percorso di assistenza del setting

Raccolta effettuata: ☐ pasto osservato ☐ osservazione parziale ☐ sole informazioni ☐ rinviata/interrotta

Motivo della raccolta parziale / rinvio; informazioni da verificare

Prima dell'osservazione: leggere G3

Non introdurre assaggi se l'assunzione orale non è prevista, è da chiarire o vi sono nuovi dubbi clinici. Non usare la scheda per ignorare indicazioni o rifiuto. In caso di segni preoccupanti, la gestione della persona viene prima della compilazione.

SCHEDA / PANORAMICA

Il pasto in sintesi

Una nota per le aree esplorate. Le pagine successive sono approfondimenti selezionabili.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

Intervallo effettivamente osservato

Alimenti A _____ / fonte e periodo delle informazioni

AREA / DETTAGLIO	EVIDENZA ESSENZIALE, CONDIZIONI E FONTE
Setting, postura, autonomia S4	
Alimenti e bevande presenti S3	
Accettazione, repertorio, esplorazione S5	
Morso, masticazione, gestione orale S6–S7	
Tempi, pause, fatica S8	
Persona, caregiver e strategie S9	
Eventi, interruzioni e azioni S10	

Limiti della panoramica: che cosa non è stato esplorato o non era osservabile

Approfondimenti utilizzati: _____

Una riga vuota non significa abilità assente. “Non rilevato” va riferito a un segno e a un intervallo specifici; non significa rischio assente. L’esito non è “sicuro / non sicuro”. Sintesi professionale: S12.

SCHEDA / REGISTRO RIPETIBILE

Alimenti e bevande osservati

Descrivi le preparazioni effettivamente presenti. Non è una proposta di alimenti da somministrare.

Codice persona: _____ Pasto P_____ Data/e: _____

A Alimento / bevanda A_____ — registrazione ripetibile

Denominazione, componenti e preparazione

Presentazione, utensile e assistenza

Caratteristiche osservate: forma/dimensioni, parti solide/liquide, temperatura e fonte

Offerto / rimasto / disperso / apparentemente assunto

Misura, stima o riferito? Metodo e limiti

IDDSI previsto dal piano, se presente: livello / fonte

Eventuale livello dichiarato o verificato: autore / data / ref.

Fonte del dato sul preparato: ☐ piano soltanto ☐ etichetta ☐ verifica documentata ☐ non disponibile

A Alimento / bevanda A_____ — registrazione ripetibile

Denominazione, componenti e preparazione

Presentazione, utensile e assistenza

Caratteristiche osservate: forma/dimensioni, parti solide/liquide, temperatura e fonte

Offerto / rimasto / disperso / apparentemente assunto

Misura, stima o riferito? Metodo e limiti

IDDSI previsto dal piano, se presente: livello / fonte

Eventuale livello dichiarato o verificato: autore / data / ref.

Fonte del dato sul preparato: ☐ piano soltanto ☐ etichetta ☐ verifica documentata ☐ non disponibile

Descrivere non equivale a classificare o attestare sicurezza

“Morbido” o “cremoso” non sono livelli IDDSI. Non dedurre il livello dall’aspetto e non confondere quello previsto con una verifica del preparato. OPA non effettua test IDDSI. Quantità visibili o stimate non misurano automaticamente l’apporto deglutito, nutrizionale o idrico. Guida: G4.

SCHEDA / SETTING E AUTONOMIA

Postura, utensili e assistenza

Annota azioni e supporti effettivi, non un livello globale di dipendenza.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

01 Setting e postura

Seduta, appoggi e posizione iniziale osservabile

Tavolo, raggiungibilità, luce, rumore e presenti

Cambiamenti durante il pasto: momento, autore, motivo e indicazione vigente richiamata

Descrivi quanto visibile; non valutare con OPA una postura "corretta" universale e non proporre manovre compensatorie.

02 Autonomia e utensili

AZIONE / UTENSILE	CHE COSA FA LA PERSONA	AIUTO EFFETTIVO / CHI / QUANDO
Scelta e accesso		
Presa / preparazione		
Trasporto alla bocca		
Pausa / fine / altro		

Informazioni riferite: fonte, periodo e differenze rispetto a questo pasto

Gli ausili abituali non sono errori. Documenta chi avvia le azioni e quali passaggi restano autonomi. Guida: G5.

SCHEDA / ACCETTAZIONE E REPERTORIO

Esplorazione, scelta e rifiuto

Nessuna sequenza obbligata: osservare o toccare non implica dover assaggiare.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

03 Episodio diretto — E _____ / alimento A _____

Che cosa precede e che cosa fa la persona: azione, parola, gesto o altro segnale

Proposta / spontaneo; chi propone e in quale modo

Risposta del partner e prosecuzione o interruzione

Caratteristiche del cibo/contesto associate all'episodio; incertezze sulla relazione

Non usare "oppositivo" o una causa sensoriale come sostituti del fatto osservato. Non introdurre pressioni, privazioni o assaggi per riempire la scheda.

04 Repertorio abituale — informazione riferita

Fonte / ruolo: _____ Periodo e contesti: _____

ALIMENTO / PREPARAZIONE	QUANDO, DOVE E COME È ASSUNTO O RIFIUTATO

Vincoli riferiti, preferenze, alternative disponibili e informazioni mancanti

Separare abitudini riferite e alimenti osservati. Nessun numero di cibi definisce una diagnosi o la qualità della dieta. Guida: G6.

SCHEDA / AZIONI ORALI VISIBILI

Morso e masticazione

Documenta il campione, senza introdurre consistenze o porzioni per mettere alla prova l'abilità.

Codice persona: _____ Pasto P_____ Data/e: _____

Alimento A_____ / episodio E_____ / fonte

Preparazione, porzione presentata, utensile e aiuti

05A Morso: che cosa è effettivamente richiesto e visibile?

☐ osservato ☐ non esplorato ☐ non osservabile ☐ non pertinente al cibo/pasto

Modalità di introduzione / eventuale distacco di una porzione; azioni della persona e del partner

Limiti della visibilità e circostanze: alimento già porzionato, presa, comfort riferito, altro

05B Masticazione: movimenti, pause e variazioni

Movimenti mandibolari visibili, eventuali asimmetrie, frammenti e pause nel campione

Momento / durata se misurata / conteggio facoltativo

Metodo, supporti, parti non osservabili

Confronto entro il campione e informazioni riferite, mantenendo distinte le fonti

Un movimento visibile non dimostra l'intero processo

Non dedurre efficacia di triturazione, forza, maturità o sicurezza della deglutizione. Nessuna soglia di tempo o di masticazioni. Non forzare l'apertura della bocca per osservare. Guida: G7.

SCHEDA / GESTIONE ORALE

Bolo, perdite e residui visibili

“Non visibile” non equivale a “assente”. Non descrivere residui faringei da un’osservazione esterna.

Codice persona: _____ Pasto P_____ Data/e: _____

Alimento A_____ / episodio E_____ / fonte

Momento e modalità di osservazione; limiti di visibilità

06A Contenimento e movimenti effettivamente osservabili

Che cosa si vede: chiusura labiale, movimenti orali, perdite anteriori o espulsione

Sequenza, permanenza visibile e risposta spontanea; che cosa non è osservabile

06B Eventuale residuo orale visibile

MOMENTO / ALIMENTO	SEDE VISIBILE E DESCRIZIONE	AZIONE SPONTANEA / SEGUITO

Informazioni riferite o documentali su residui: fonte, data e sede riportata

Limite della scheda

Non introdurre dita o utensili e non forzare un’ispezione per completare OPA. Non usare l’assenza di residui visibili, tosse o altri segni per attestare la sicurezza della deglutizione. Un intervento clinico necessario segue le procedure appropriate, non le istruzioni di compilazione. Guida: G3 e G7.

SCHEDA / ANDAMENTO TEMPORALE

Tempi, pause e affaticamento

Distingui l'intervallo osservato dall'intera durata del pasto e la fatica riferita da ciò che vedi.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

Inizio/fine del pasto, se noti — fonte

Intervallo osservato — modalità di rilevazione

Situazione iniziale / comfort riferito

Assunzioni o pause precedenti, se note — fonte

MOMENTO	AZIONE, PAUSA O CAMBIAMENTO	FORTE / MOTIVO RIFERITO / RISPOSTA

Fatica, dolore, fame o sazietà riferiti dalla persona: parole / segnale e modalità comunicativa

Cambiamenti osservati e limiti: cosa può essere descritto senza attribuirne la causa

Motivo e autore della conclusione / interruzione

Eventuali eventi richiamati in S10 — E _____

Non usare durata o numero di assunzioni come soglia di normalità. Le pause possono avere motivi differenti. Segni nuovi o preoccupanti richiedono gestione appropriata, non ulteriori prove per completare il confronto. Guida: G3 e G8.

SCHEDA / PERSONA E CAREGIVER

Comunicazione, aiuti e strategie

Mantieni distinta la prospettiva della persona da quella del partner.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

09 Interazione nel pasto — episodio E _____

Segnale della persona: scelta, richiesta, rifiuto, altro

Risposta del partner: parole, attesa, aiuto e contesto

Partecipazione e comportamento descritti senza attribuire intenzioni o cause

10 Strategie spontanee o già previste — non una prova di trattamento

AZIONE / CHI LA AVVIA	CONDIZIONI PRIMA / DOPO	RISULTATO VISIBILE E LIMITI

Preferenze e impatto riferiti dalla persona

Esperienza, bisogni e carico riferiti dal caregiver

Indicazioni vigenti richiamate / informazioni da condividere con il referente

Un risultato apparentemente favorevole non dimostra sicurezza deglutitoria. Non trasferire automaticamente una strategia ad altri cibi o persone. La scheda non prescrive postura, utensili, addensanti, volumi o manovre. Guida: G9.

SCHEDA / EVENTI E AZIONI · RIPETIBILE

Evento, interruzione e comunicazioni

La gestione della persona viene prima della documentazione. Guida: G3 e G8.

Codice persona: _____ Pasto P _____ Data/e: _____

Non attendere un esito OPA

In caso di emergenza, attiva immediatamente i soccorsi e le procedure locali. Se compaiono segni nuovi o preoccupanti durante l'assunzione, interrompi l'offerta e attiva il referente secondo il piano del servizio. Non fare nuovi assaggi per confermare o escludere il problema.

Episodio E _____ / ora o fase del pasto

Fonte: diretta / riferita / documentale; autore e data

Che cosa precede l'evento: alimento A _____, posizione, utensile, aiuto e stato iniziale

Fatto osservato o parole riferite: descrizione, andamento e cambiamento rispetto all'inizio

Azioni adottate, da chi e quando; eventuale interruzione dell'offerta e dell'osservazione

Chi è stato contattato / ora / modalità

Risposta, indicazione ricevuta / autore / data

Seguito documentato, informazioni ancora da verificare e responsabilità del passaggio

Professionista / firma: _____

L'evento non costituisce una diagnosi; la scheda non autorizza la ripresa del pasto. Assenza di tosse o cessazione del segno non dimostrano assenza di aspirazione. Conservare il riferimento al piano o alla decisione clinica pertinente.

SCHEDA / CONFRONTO FACOLTATIVO

Pasti e contesti a confronto

Confronta solo ciò che è documentato, senza cambiare il pasto per costruire il confronto.

Codice persona: _____ Data di compilazione: _____

CHE COSA CONFRONTO	PASTO / SITUAZIONE A	PASTO / SITUAZIONE B
Codice, data, fonte e periodo		
Luogo, partner, momento e durata osservata		
Alimento, preparazione, utensile e piano richiamato		
Setting, supporti, assistenza e stato iniziale		
Azioni della persona, pause e partecipazione		
Eventi, interruzioni e azioni documentate		

Che cosa è confrontabile e quali differenze impediscono una conclusione

Domanda da approfondire e dati necessari, senza provocare nuove prove

Un resoconto domestico e un episodio diretto nel servizio non sono misure equivalenti. Non sommare risultati o ricavare miglioramento, peggioramento o sicurezza da condizioni differenti. Guida: G9.

SCHEDA / SINTESI PROFESSIONALE

Profilo osservativo del pasto

Sintesi qualitativa, senza punteggi e senza conclusioni automatiche sulla deglutizione.

Codice persona: _____ Data di compilazione: _____

Ambito: pasti, alimenti, fonti, periodi e pagine utilizzate

Risorse osservate e condizioni che hanno favorito autonomia e partecipazione

Bisogni, variabilità, limiti e informazioni mancanti

Sintesi del professionista — collegare i fatti alle fonti, senza attribuire una diagnosi con OPA

Priorità della persona / caregiver, con fonte

Eventi e azioni già documentati — riferimenti S10

Aspetti da approfondire, referenti, responsabilità e tempi concordati per il seguito

Documenti collegati: _____

Professionista / firma: _____

Questa sintesi non attesta la sicurezza del pasto

Non esclude disfagia o aspirazione e non sostituisce valutazione clinica, esami strumentali quando indicati o protocolli validati. Non equivale a prescrizione di dieta, consistenze, volumi o assistenza. Le decisioni cliniche vanno documentate nei percorsi appropriati.